

Seminário PNE — roteiro de fala e guia de estudo

Oct 3, 2026 · @Thamyres Tosarelli

Este arquivo tem duas partes. A Parte 1 explica o conteúdo em linguagem simples, para você entender e não precisar decorar. A Parte 2 traz, slide por slide, o que falar.

Como usar este arquivo

Estude a Parte 1 primeiro, e só depois decore o roteiro. Quem entende a lógica improvisa bem; quem só decora trava na primeira pergunta.

Uma ordem que funciona:

1. Leia a Parte 1 inteira uma vez, sem anotar nada.
2. Leia a tabela dos aparelhos duas vezes. Ela é o coração do trabalho.
3. Faça o “Teste-se”. O que você errar, volte e releia só aquele pedaço.
4. Só então leia a Parte 2, com os slides abertos do lado.
5. Ensaie em voz alta duas vezes, cronometrando.

Não decore frase por frase. Decore a sequência: **problema → barreira → aparelho → cuidado**. Ela se repete em quase todo slide.

Tempo: 32 minutos de fala + 10 de discussão. Se apertar, corte o slide 19 (medicamentos) e encurte o 13 e o 15 — isso tira 5 minutos e não quebra o argumento.

Parte 1 — A ideia que segura tudo

O seminário inteiro defende **uma frase só**: o que impede o atendimento não é a deficiência da pessoa, é o consultório que não foi feito para ela. E cada aparelho que eu vou mostrar tira um pedaço desse impedimento.

Se você entender isso, o resto se encaixa sozinho. São quatro passos:

1. **A barreira não está na pessoa, está no encontro.** Um cadeirante não “não consegue entrar”; ele não entra onde só tem escada. Um autista não “não colabora”; ele não aguenta um refletor na cara e o barulho da alta rotação. Mude o consultório e a mesma pessoa passa a ser atendida.
2. **O que importa é a função, não o diagnóstico.** Saber que ele tem síndrome de Down não diz o que fazer. Saber que ele não aguenta barulho, que não fala e que se mexe muito — isso diz. São quatro perguntas: ele se mexe sozinho? ele aguenta barulho e luz forte? ele

consegue dizer o que sente? ele entende o que vai acontecer? Cada resposta aponta um aparelho.

3. Comece sempre pelo degrau mais baixo. A escada é: adaptar a sala → usar aparelho → segurar o paciente → sedar → anestesia geral. Quanto mais embaixo, menos invasivo. E cada aparelho que você usa em cima evita um degrau lá embaixo: um fone bem usado pode evitar uma sedação.

4. O que mais funciona é o que custa menos. A fama está nos aparelhos caros, mas os estudos mais fortes estão na sala adaptada, nos cartões com figuras e na escova elétrica. O escâner e a inteligência artificial ainda quase não foram testados em pacientes com deficiência.

Frase de fechamento, para decorar: **a tecnologia não torna o paciente capaz de ser atendido — ela torna o atendimento capaz de receber o paciente.**

Os aparelhos, um por um

Esta tabela é o coração do trabalho. Se você souber dizer, de cada linha, **o que é, para que serve e o que cuidar**, você sabe a apresentação.

Aparelho	O que é	Para que serve	O que cuidar	Custo
Cartões com figuras	Cartões plastificados com desenhos de cada passo da consulta	Mostrar antes o que vai acontecer	Use fotos da sua própria sala, não da internet	Quase nada
Vídeo da consulta	Vídeo de um minuto gravado por você, visto em casa	Tirar o susto; ele chega sabendo	A família precisa ver em casa, não na sala de espera	Quase nada
Luz indireta	Apagar o refletor e trabalhar com a luz do teto	Tirar o desconforto da luz na cara	Você enxerga menos: combine luz pontual só na hora	Quase nada
Fone com cancelamento	Fone de ouvido comum, dos que abafam o som	Cortar o barulho da alta rotação	Não serve para quem não tolera pressão na orelha	Pouco

Aparelho	O que é	Para que serve	O que cuidar	Custo
Avental de peso	O próprio avental de chumbo, posto no colo	O peso acalma; muita gente relaxa na hora	É conforto, nunca contenção	Quase nada
Prancha de figuras	Cartões com “dói”, “pausa”, “água”, “acabou”	Ele avisar o que está sentindo	Combine o sinal de parar antes de começar	Quase nada
Celular com VLibras	Aplicativo gratuito que traduz texto para Libras	Conversar com quem é surdo	Não substitui o intérprete, que é direito dele	Quase nada
Escala de carinhas	Régua com rostos, do sem dor ao com muita dor	Medir dor em quem não fala	Quem nem aponta: observe rosto, corpo e som	Quase nada
Escova elétrica	Escova com motor, que faz o movimento sozinha	Limpar o que a mão do cuidador não alcança	Ensine o cuidador ali, com a escova na mão	Pouco
Flúor que para a cárie	Diamino fluoreto de prata, um líquido pintado na cárie	Parar a cárie sem broca e sem anestesia	A mancha fica preta e não sai: avise e registre antes	Pouco
Gel anestésico	Pomada no algodão, antes da picada	Tirar a dor da agulha entrando	Só funciona se você esperar os dois minutos	Quase nada
Aparelho de vibração	Vibrador encostado ao lado do lugar da picada	Abafar a dor da agulha	Não substitui a técnica, só ajuda	Pouco
Caneta de anestesia	Seringa em forma de caneta, com motor	Injetar devagar e sempre na mesma pressão	É mais lenta, e não dispensa o gel antes	Caro
Raio-X digital	Sensor ligado ao computador, sem filme	Imagem na tela na hora, até na cadeira de rodas	O sensor é duro e dá ânsia: prefira placa de fósforo	Médio
Câmera intraoral	Canetinha com câmera na ponta	Mostrar a boca na tela para o cuidador ver	Ela mostra, mas não diagnostica	Médio

Aparelho	O que é	Para que serve	O que cuidar	Custo
Escâner intraoral	Câmera que tira a medida da boca	Substituir a moldagem com massa; menos engasgo	Quase não foi testado em pacientes com deficiência	Caro
Inteligência artificial	Programa que marca pontos suspeitos na radiografia	Um segundo olhar no diagnóstico	Quem decide o tratamento continua sendo você	Caro
Óculos de realidade virtual	Óculos que ocupam a visão e a audição com um vídeo	Distrair durante o procedimento	Não usar em epilepsia por luz nem em quem lê lábios	Caro
Laser de baixa potência	Luz que não corta nada	Cicatrizar afta, ferida e dor na articulação	Exige curso e óculos de proteção na sala	Médio
Laser de alta potência	Laser que tira a cárie no lugar da broca	Tratar sem barulho e sem tremida	Mais devagar em cavidade grande	Caro
Óxido nitroso	Gás pela mascarinha no nariz	Sedação leve, que você regula na hora	Não serve com o nariz entupido	Médio
Capnógrafo	Monitor que mede o ar que o paciente solta	Avisar a parada da respiração antes do oxímetro	Obrigatório se a clínica faz sedação	Caro

Olhe a coluna do custo. Os aparelhos de “quase nada” são os que têm mais estudo por trás. Os caros são os que ainda têm menos. Esse contraste é o argumento mais forte do seu seminário.

Os poucos números que vale guardar

São seis. Não precisa decorar mais do que isso — nos slides eles quase não aparecem de propósito, para a tela ficar limpa. Guarde para usar se alguém perguntar.

Número	O que ele diz	De onde vem
14 milhões	Brasileiros com alguma deficiência, quase 1 em cada 14 pessoas	Censo 2022
2 vezes mais	Problemas de boca nessa população, comparada com o resto	Relatório da OMS, 2022
220 crianças	Tamanho do estudo da sala adaptada, o mais forte da área	JAMA Netw Open, 2023
113 crianças	Tamanho do estudo dos cartões com figuras	Children, 2022
2 consultas viraram 1,5	O que o vídeo antes da consulta economizou	J Autism Dev Disord, 2024
9 em cada 10	Cáries que a inteligência artificial encontra na radiografia	Clin Exp Dent Res, 2024

Se a cabeça travar na hora, lembre só de três: **14 milhões, o dobro de problemas de boca e 220 crianças**. Com esses três você sustenta a abertura e o fechamento.

As leis, em três frases

São cinco documentos, mas você só precisa saber três coisas.

1. A LBI (Lei 13.146/2015) diz que a barreira está no ambiente, não na pessoa. É dela que sai o argumento central do seu trabalho. Ela também garante que a pessoa receba a informação num formato que ela entenda — é por isso que cartões com figuras e VLibras não são gentileza, são cumprimento da lei. E presume que a pessoa com deficiência é capaz de decidir sobre si.

2. A norma ABNT 9050 diz as medidas. Rampa, porta larga, banheiro com barras, balcão rebaixado. É norma técnica: não é opção de quem monta o consultório.

3. A Resolução CFO 226/2020 proíbe atender a distância. Nada de consulta, diagnóstico, receita ou plano de tratamento pela tela. O que pode é **orientar**: mostrar ao cuidador como escovar, tirar dúvida entre consultas, acompanhar. Essa diferença cai em prova.

E uma distinção que vale ouro se perguntarem: adaptar o consultório é **obrigação, não cortesia**. Ninguém vai sortear quem recebe rampa e quem não recebe para provar que rampa funciona — seria antilógico, do mesmo jeito que seria estranho sortear quem usa paraquedas. Acessibilidade não é hipótese a ser testada, é exigência legal.

As cinco perguntas que podem cair

São os pontos em que quase todo mundo erra. Decore a primeira palavra da resposta e o resto vem.

1. “Dá para diagnosticar pelo celular?” Não. A Resolução CFO 226/2020 proíbe consulta, diagnóstico, receita e plano de tratamento a distância. O que pode é orientar e acompanhar. *Por que pega:* porque todo mundo viu teleconsulta na pandemia e acha que vale igual na odontologia.

2. “A deficiência proíbe o vasoconstritor?” Não. A deficiência, sozinha, nunca contraindica. Quem contraindica é a doença que a pessoa tem junto — cardiopatia grave, arritmia não controlada. E tirar o vasoconstritor por rotina é ruim: a anestesia dura menos e você acaba tendo que repicar no meio. *Cuidado extra:* a dose máxima é pelo peso, e muito adulto com deficiência pesa bem menos do que parece.

3. “Se a deficiência intelectual é grave, já vai direto para a anestesia geral?” Não. O grau da deficiência não prediz o quanto a pessoa aguenta a consulta. Tem paciente com deficiência grave que colabora com uma prancha de figuras e um fone, e tem paciente leve que não tolera nada. A pergunta certa nunca é “qual o diagnóstico”, é “o que essa pessoa aguenta hoje”.

4. “Por que indicar escâner e inteligência artificial se os estudos excluíram pacientes com deficiência?” Essa é a pergunta mais difícil, e também a que mais impressiona se você responder bem. Responda: porque os estudos mostram que o aparelho funciona, mas não provam que funciona *nesse* paciente — então eu indico com cautela e digo isso em voz alta. E tem uma ironia aí: os estudos excluem justamente quem mais se beneficiaria de um exame rápido e sem moldagem.

5. “Conter o paciente é proibido?” Não é proibido, mas tem regra. Só depois que o menos invasivo falhou, nunca como castigo nem para apressar, com autorização própria e separada da do tratamento, e anotando motivo, tipo e duração. Sem isso, deixa de ser conduta clínica. E a ponte com o seu tema: cada aparelho usado antes tira um motivo de precisar conter.

Teste-se

Responda em voz alta antes de olhar o gabarito. O que você errar, volte e releia só aquele pedaço.

1. Onde está a barreira: na pessoa ou no consultório?
2. Quais são as quatro perguntas que você faz antes de escolher o aparelho?
3. Qual a ordem dos cinco graus, do menos ao mais invasivo?
4. Qual recurso tem a evidência mais forte da área?

5. Para que serve a prancha de figuras, e o que combinar antes de começar?
6. Por que o flúor que para a cárie precisa de aviso antes?
7. Em quem não se usa o óculos de realidade virtual?
8. Qual aparelho é obrigatório quando a clínica faz sedação, e por quê?
9. O que a Resolução CFO 226/2020 proíbe, e o que ela permite?
10. Qual a frase de fechamento do seu seminário?

Gabarito

1. No consultório — melhor ainda: no encontro entre a pessoa e um lugar que não foi feito para ela.
2. Ele se mexe sozinho? Aguenta barulho e luz forte? Consegue dizer o que sente? Entende o que vai acontecer?
3. Adaptar a sala → usar aparelho → segurar o paciente → sedar → anestesia geral.
4. A sala sensorialmente adaptada — luz indireta, fone, avental de peso, primeiro horário. Estudo com 220 crianças, com medida no corpo delas.
5. Para ele avisar dor, pausa, sede, fim. Antes de começar, combine o sinal de parar — levantar a mão já serve.
6. Porque a cárie fica com uma mancha preta permanente. O consentimento estético vem antes da aplicação.
7. Em quem tem epilepsia que piora com luz piscando, em quem não tolera pressão no rosto e em quem lê lábios — o óculos tapa o seu rosto.
8. O capnógrafo. Ele mede o ar que o paciente solta e avisa a parada da respiração bem antes de o oxímetro cair.
9. Proíbe consulta, diagnóstico, receita e plano de tratamento a distância. Permite orientação e acompanhamento.
10. A tecnologia não torna o paciente capaz de ser atendido — ela torna o atendimento capaz de receber o paciente.

Parte 2 — O que falar, slide a slide

O que está entre aspas é para falar. O que está em itálico é instrução para você, não fale.

Slide 1 · Capa

“Boa tarde. Meu tema é tecnologia e acessibilidade para pacientes com necessidades especiais. Eu não vou falar das condições em si — isso os outros grupos fazem. Eu vou falar dos aparelhos: o que é cada um, para que serve e o que cuidar.”

Não demore aqui. Dez segundos e passe.

Slide 2 · O problema não é a boca, é o consultório

“Catorze milhões de brasileiros têm alguma deficiência. É quase uma em cada catorze pessoas — ou seja, numa sala do tamanho desta, tem gente.”

“E essas pessoas têm o dobro de problemas de boca que o resto da população. Não por causa da deficiência em si: por causa do consultório que não foi feito para elas.”

Pausa de um segundo depois do “dobro”. É o número que fica.

Slide 3 · Três coisas impedem o atendimento

“Quando a gente destrincha, são três coisas. Um: ele não consegue entrar — escada, porta estreita, banheiro sem barra. Dois: ele não consegue avisar — não fala, ou fala e ninguém entende. Três: ele não suporta o aparelho — a luz, o barulho, a vibração.”

“Guardem essas três. Cada aparelho que eu vou mostrar resolve uma delas.”

Slide 4 · Quatro perguntas antes de escolher o aparelho

“Antes de escolher qualquer coisa, eu faço quatro perguntas. Ele se mexe sozinho? Ele aguenta barulho e luz forte? Ele consegue dizer o que sente? Ele entende o que vai acontecer?”

“Repare numa coisa: nenhuma delas pergunta o nome da doença. Porque o diagnóstico não me diz o que fazer — a função me diz.”

Essa frase costuma chamar atenção. Diga devagar.

Slide 5 · Cada aparelho em cima evita um degrau lá embaixo

“Esta é a escada do atendimento. Em cima, adaptar a sala. Depois, usar aparelho. Depois, segurar o paciente. Depois, sedar. E em último, anestesia geral.”

“A regra é começar sempre pelo degrau mais alto. E o ponto do meu trabalho é este: cada aparelho que eu uso lá em cima evita um degrau lá embaixo. Um fone de trinta reais pode evitar uma sedação.”

Slide 6 · Os aparelhos, organizados por preço

“Aqui estão todos os aparelhos que eu vou mostrar, separados não por tipo, mas por preço. Na primeira coluna, o que custa quase nada. Na segunda, o que custa pouco. Na terceira, o que custa caro.”

“Guardem isso, porque eu volto nisso no final: a primeira coluna é a que tem mais estudo por trás.”

Percorra as colunas com o dedo, não leia item por item.

Slide 7 · O celular, antes do paciente chegar

“O primeiro aparelho não está no consultório, está no bolso. Antes da consulta, o celular serve para muita coisa: mandar as fotos da sala, combinar o horário mais vazio, perguntar o que incomoda esse paciente, mostrar ao cuidador como escovar.”

“O que não pode: diagnosticar, receitar ou fazer plano de tratamento pela tela. Isso a Resolução 226 do CFO proíbe. Orientar, pode.”

Slide 8 · Mostrar antes, para não assustar depois

“O aparelho aqui são cartões com figuras, ou um vídeo de um minuto. É uma sequência mostrando, passo a passo, o que vai acontecer na cadeira.”

“A família vê em casa umas três vezes nos dias antes, e no dia eu sigo exatamente a mesma ordem das fotos.”

“E tem um cuidado que faz toda a diferença: fotografe a sua própria sala, com o seu jaleco. Foto da internet não serve — ele precisa reconhecer o lugar.”

Slide 9 · Baixar o volume da sala

“Esta é a sala de sempre: refletor apontado no rosto, barulho da alta rotação, gente entrando e saindo.”

“E esta é a sala adaptada: luz indireta, fone que corta o ruído, avental de peso no colo, vídeo devagar no teto, primeiro horário com a sala vazia.”

“Por que isso muda tudo: muita coisa que a gente chama de mau comportamento é só desconforto com luz e barulho. Tirando o desconforto, o paciente colabora. E isso dá para medir no corpo dele, no suor e nos batimentos — foi assim que testaram, em 220 crianças.”

“E repare: não precisa de obra nem de compra cara.”

Este é o slide mais forte da apresentação. Não corra.

Slide 10 · Óculos de realidade virtual

“O óculos ocupa a visão e a audição com um vídeo, para o paciente não acompanhar o que a minha mão está fazendo. Ele sente menos dor e fica menos ansioso.”

“Mas tem três situações em que não dá: epilepsia que piora com luz piscando, quem não aguenta nada apertado no rosto, e quem lê lábios — porque o óculos tapa o meu rosto e o paciente perde a comunicação.”

“E tem uma alternativa mais barata e mais segura: uma TV ou um tablet preso no teto faz quase o mesmo efeito, com o rosto livre.”

Slide 11 · Se ele não consegue avisar, você trabalha no escuro

“Três recursos aqui. A prancha de figuras: cartões plastificados com dói, pausa, água, acabou — ele aponta. O celular com o VLibras, que é gratuito e traduz para Libras o que eu escrevo. E a escala de carinhas, para ele apontar o quanto dói.”

“E uma coisa que vale para todos: combine o sinal de parar antes de começar. Levantar a mão já serve.”

“Sem um jeito de ele dizer ‘para’, eu não tenho consentimento de verdade — eu tenho um papel assinado.”

Pausa depois dessa frase.

Slide 12 · O que conferir no consultório

“Antes de dizer que o consultório atende, dá para conferir. Do portão até a recepção: rampa, vaga, porta larga, corredor onde a cadeira gira, banheiro com barras, balcão com parte baixa.”

“Da recepção até a cadeira: braço que sai para entrar de lado, prancha e cinto para transferir, placa em braille, prancha de figuras à mão, sala silenciosa e consulta com tempo a mais.”

“E uma coisa que quase ninguém sabe: em quem tem espasticidade forte, atender na própria cadeira de rodas é mais seguro do que transferir.”

Volte à tela e lembre: isso não é melhoria opcional, é norma e é lei.

Slide 13 · Menos tempo de boca aberta

“Quatro aparelhos de diagnóstico. O raio-X digital dá a imagem na tela na hora, e dá para fazer com o paciente na própria cadeira de rodas — mas o sensor é duro e dá ânsia, então a placa de fósforo incomoda menos.”

“A câmera intraoral é uma caneta com câmera que joga a boca na tela. Ela serve menos para mim e mais para o cuidador, que vê com os próprios olhos a sujeira que ficou.”

“O escâner tira a medida da boca sem massa de moldagem, o que diminui o risco de engasgo. E a inteligência artificial marca na radiografia os pontos suspeitos de cárie.”

“Os dois últimos têm o mesmo problema, e eu volto nele daqui a pouco: quase não foram testados em pacientes com deficiência.”

Slide 14 · Tirar o medo da agulha

“Três aparelhos. A caneta computadorizada parece uma caneta, não uma seringa: um motorzinho empurra o anestésico devagar e sempre na mesma pressão — e é a pressão rápida que dói.”

“O aparelho de vibração fica encostado ao lado da picada. A vibração chega antes ao cérebro e abafa a dor. É o mesmo truque de esfregar o lugar onde a gente bateu.”

“E o gel anestésico, que é o mais barato de todos e o mais esquecido. Só funciona se você esperar de verdade os dois minutos.”

Aponte os quatro avisos de segurança embaixo, sem ler todos. Leia só o do peso e o do lábio dormente.

Slide 15 · Laser

“São dois lasers diferentes. O de baixa potência não corta nada: é uma luz que acelera a cicatrização, para afta, ferida na boca e dor na articulação do queixo.”

“O de alta potência tira a cárie no lugar da broca, muitas vezes sem precisar de anestesia, e sem o barulho e a tremida da alta rotação.”

“E agora a parte que quase ninguém conta: ele é mais devagar em cavidade grande, custa caro, exige curso e óculos de proteção para todo mundo na sala — e os estudos foram feitos em crianças sem deficiência.”

Slide 16 · Quem escova a boca dele não é você

“O paciente passa uma hora comigo e vinte e três com o cuidador. Então parte dos aparelhos é para a casa.”

“A escova elétrica faz o movimento que a mão do cuidador não consegue fazer dentro da boca de outra pessoa. O flúor que para a cárie é um líquido pintado na lesão, que em segundos faz ela parar de crescer — com um aviso: a mancha fica preta e não sai.”

“E o resto é simples: cabo de escova engrossado, abridor de silicone, lembrete no celular com a rotina em figuras.”

“Ensinar o cuidador a escovar é tratamento. Não é recado no fim da consulta.”

Slide 17 · Se vai sedar, o aparelho que importa é o monitor

“Às vezes não dá mesmo, e aí a gente sobe a escada. O óxido nitroso é o gás que vai pela mascarinha no nariz: eu aumento e diminuo na hora, e ele acorda lúcido em poucos minutos.”

“Mas o aparelho que importa aqui não é o que acalma, é o que vigia. O capnógrafo mede o ar que o paciente solta e avisa que ele parou de respirar bem antes de o oxímetro cair. Por isso é exigido por diretriz na sedação.”

“A anestesia geral resolve o tratamento, mas não resolve a causa. Sem prevenção depois, o paciente volta para a fila da cirurgia. Então, pensando em custo, o recurso que mais compensa é o que evita a segunda anestesia geral.”

Esse raciocínio costuma impressionar. Diga olhando para a turma.

Slide 18 · Segurar o paciente é o último recurso

“Segurar não é proibido, mas tem regra: só depois que o menos invasivo falhou, nunca como castigo nem para apressar, com autorização própria separada da do tratamento, e anotando motivo, tipo e duração.”

“E aqui está a ligação com tudo o que eu mostrei: cada aparelho tira um motivo de precisar segurar. A sala adaptada tira o estouro por luz e barulho. As fotos tiram o susto. O escâner tira a massa de moldagem da boca. O laser tira o barulho e a tremida.”

“E para ele entender o que está assinando: papel com figuras, vídeo antes da assinatura, Libras ou áudio.”

Slide 19 · O remédio que ele toma aparece na boca

“Esta tabela é consulta rápida, não é para decorar. O remédio de epilepsia faz a gengiva crescer por cima do dente. O de pressão, também. Os antipsicóticos deixam a boca seca e fazem ranger os dentes. O anticoagulante faz sangrar mais.”

“E tem um aparelho aqui também, que é o aplicativo de interação: quem toma seis, oito remédios por dia não cabe na memória de ninguém. Conferir antes de receitar é item de segurança.”

Se o tempo estiver curto, este é o slide para encurtar.

Slide 20 · No que dá para confiar hoje

“Este slide é o resumo de tudo. Olhem as duas últimas colunas juntas.”

“Tudo o que tem confiança alta custa quase nada ou pouco: a sala adaptada, os cartões, o vídeo, a escova elétrica, o flúor. E o que custa caro — escâner e inteligência artificial — ainda tem confiança baixa, porque quase não foi testado em pacientes com deficiência.”

Pausa longa aqui. É a virada do argumento.

Slide 21 · Se o dinheiro é curto, comece por aqui

“Então, na prática: se amanhã você tivesse pouco dinheiro, começaria pelos cartões, por apagar o refletor, por emprestar um fone, por marcar o primeiro horário. Depois escova elétrica, vídeo da consulta, flúor que para a cárie, prancha de figuras.”

“E deixaria para quando pudesse comprar: capnógrafo, caneta de anestesia, óculos de realidade virtual, escâner, laser.”

“Ter pouco dinheiro não impede ninguém de atender bem o paciente com deficiência. O que impede é não adaptar o que já dá para adaptar.”

Slide 22 · Conclusão

“Para fechar, três respostas. O que ainda trava: o atendimento concentrado em poucos centros, os estudos que excluem justamente quem mais precisaria, a faculdade que ensina pouco disso, e o preconceito, que não custa nada e é o mais difícil de tirar.”

“Como atender com segurança: descobrir antes o que ele aguenta, começar pelo menos invasivo, monitorar, guardar as autorizações e chamar de volta a cada três ou quatro meses.”

“E em que isso tudo se apoia: estudos clínicos, revisões e as normas brasileiras.”

“E eu fecho com a frase que resume o trabalho inteiro: a tecnologia não torna o paciente capaz de ser atendido — ela torna o atendimento capaz de receber o paciente.”

Pare depois dessa frase. Não emende nada.

Slide 23 · Discussão

Este slide é para a turma, não para você falar sozinha. Leia as três perguntas e deixe responderem.

As respostas, se ninguém souber: não dá para diagnosticar pela tela, o CFO proíbe; a deficiência não proíbe o vasoconstritor; o recurso com mais estudo é a sala adaptada.

E as três perguntas de debate estão na tela: por que só se fala dos aparelhos caros, se dá para indicar escâner e inteligência artificial sem estudo em PNE, e se adaptar a sala é obrigação ou gentileza.

“Para fechar, eu queria que cada um dissesse uma adaptação de custo zero que daria para fazer amanhã na clínica-escola.”

Slide 24 · Referências

Deixe este slide na tela enquanto respondem. Não leia nenhuma referência em voz alta.

“Estão todas aqui, com ano e revista, se alguém quiser conferir depois.”

Os erros que derrubam a apresentação

Nenhum deles tem a ver com conteúdo. São todos de execução.

- **Ler o slide.** O slide é o apoio, você é a explicação. Se você ler, a turma lê mais rápido que você fala e para de ouvir.
- **Falar de doença.** O seu tema é aparelho. Se escapar para explicar autismo ou paralisia cerebral, você invade o trabalho dos outros grupos e perde tempo.
- **Correr nos slides 9 e 20.** São os dois mais fortes. Se tiver que correr em algum lugar, corra no 19.
- **Despejar número.** Os números estão quase todos fora da tela de propósito. Use um ou outro, e só se perguntarem.
- **Pedir desculpa.** Nada de “desculpa, ficou corrido” ou “acho que é isso”. Termine na frase de fechamento e pare.
- **Não saber dizer “não sei”.** Se perguntarem algo que você não sabe: “não sei, mas o caminho para responder seria olhar tal coisa”. Isso soa melhor do que inventar.

E um lembrete de ensaio: cronometre duas vezes em voz alta, de pé. Ler em silêncio sempre dá um tempo menor do que o real.